リハ医療デイリー

REHA MEDICAL DAILY

2026年11月13日（金）

第62号　朝刊

きょうの紙面　▸ リハ栄養 × 大腿骨骨折　▸ 脳卒中 × 痙縮予防　▸ 医療AI × 臨床推論　▸ 短信 8本

■ リハ栄養 × 大腿骨骨折

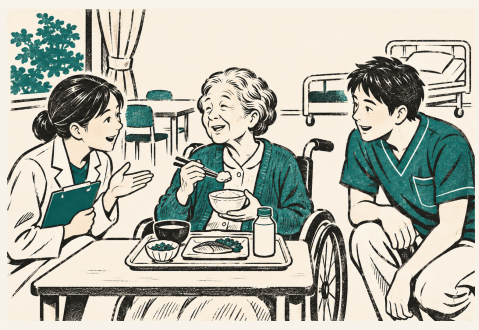
大腿骨骨折の栄養療法「強い推奨」に格上げ

リハ栄養診療ガイドライン2026　対象は11領域に、脳卒中・嚥下は弱い推奨

日本リハビリテーション栄養学会が「リハビリテーション栄養診療ガイドライン2026」をまとめ、全推奨を収めた英文要約がJMA Journalに無料で公開された。日本語の本体は学会誌に載る。2018年の初版は4領域だったが、今回は脳血管疾患、大腿骨近位部骨折、COPD、がん、嚥下障害、口腔管理、薬剤師の介入、入院関連サルコペニア、健康の社会的決定要因などの11領域に広がった。推奨を付けた臨床疑問は12問ある。

大腿骨近位部骨折でリハを受ける人には、強化型の栄養療法を併せて行うことが「強い推奨」となった（前版は弱い推奨）。RCTの統合で、ADL・握力・BMIの改善、在院日数の短縮、合併症の減少がみられ、死亡も減る傾向があった。明らかな有害事象は報告されていない。ただし、エビデンスの確実性は4段階で下から2番目の「C」で、費用対効果も分かっていない。

脳卒中の急性期と回復期、COPD、がん、嚥下障害の強化栄養療法は弱い推奨にとどまった。管理栄養士による評価・指導と口腔管理も弱い推奨で加わった。回復期の大腿骨骨折では、食べた量と体重の確認、栄養の相談をリハの計画に最初から組み込むことが標準になる。



食べることも、リハの一部として数える。

出典 JMA Journal（日本リハビリテーション栄養学会）↗

数字で見る

11 領域	12 問	C
ガイドラインの対象	推奨を付けた臨床疑問	骨折の推奨のエビデンス確実性

■ 脳卒中 × 痙縮予防

発症早期のrTMS3回で上肢の痙縮が少なく

発症7～30日の脳卒中70人を、健側の一次運動野への低頻度rTMS（1Hz・1000発）を3回行う群と偽刺激の群に35人ずつ分けた。rTMS群は1か月・3か月とも上肢のすべての関節で痙縮が少なく、握力、痛み、3か月のmRSも良好だった。軽い頭痛やふらつきは5人だった。

3か月時点で偽刺激群が痙縮になるオッズは肩15.3倍、手指26.3倍と大きいが、信頼区間は手指で5.2～132.9と広い。1施設・小規模の結果で、痙縮を出る前に防ぐ試みとして多施設の追試が要る。



出典 Stroke↗

■ 医療AI × 臨床推論

AIに記録を書かせる前に自分の見立てを口に出す

診察の会話からカルテを書くAIスクライブは、正確さや同意の議論が中心だった。豪メルボルン大などの論考は、ベテランの腕が鈍る、新人が最初から身につけない、AIの誤りを正しいと覚える、の3つの危うさを分けた。

対策として、AIが記録を出す前に、まとめと計画を自分の言葉で口に出す方法を提案した。効果はまだ確かめられていない。リハの評価や記録でもAIの下書きが増える中、新人教育に取り入れやすい習慣になりそうだ。



出典 JAMIA↗

短信

〈脳卒中〉**多職種の週1回の目標設定を合意で作成**

脳卒中リハで多職種が週ごとにSMART目標を立てる枠組み。専門家12人の合意で効果は未検証。 出典 PubMed↗

〈脳卒中〉**高齢者の疲労、不安と睡眠が鍵**

脳卒中の高齢者234人の横断研究。不安・抑うつ・睡眠の質が疲労との関係の7割を媒介した。 出典 PubMed↗

〈心臓リハ〉**低用量HIITは負荷が大きい**

英国の外来心臓リハで冠動脈疾患18人を比較。20分の低用量HIITは中強度持続運動より酸素摂取・乳酸・きつさが高かった。 出典 PubMed↗

〈心臓リハ〉**心理支援がある施設で目標達成**

スウェーデン全78施設と患者6,755人の分析。心理社会的支援や看護師の薬の調整手順がある施設で、LDLと血圧の目標達成が多かった。 出典 Eur J Cardiovasc Nurs↗

〈高齢者〉**オタゴ運動で歩行速度が改善**

中国の60歳以上51人のRCT。週1回の改良版オタゴ運動12週で歩行速度が0.14m/s上がった。 出典 PubMed↗

〈OT・ST〉**パーキンソン病の食事評価は2つだけ**

食事動作を観察で測る評価法は2つだけで、どちらも内容妥当性が未検証だった。 出典 Disabil Rehabil↗

〈肩〉**肩甲上神経の電気刺激は差なし**

慢性の腱板関連の肩の痛み63人の二重盲検RCT。超音波ガイド下の経皮電気刺激1回は、筋力も痛みも偽刺激と差がなかった。 出典 PubMed↗

〈制度〉**地方勤務医の特別手当を検討**

社保審・医療部会が、医師偏在対策で2028年度に始まる地方勤務医への特別手当の詳細を、今冬からWGで議論すると決めた。 出典 GemMed↗